

Fecha Última Actualización: 25-01-2023 12:05:40

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Hugo Antonio Martínez Silva
Edad : 71a 3m 7d
Dirección : Ranquilco Alto S/N

Rut : 6.971.307-6
Fecha Nacto: 18/10/1951
Comuna : Nueva Imperial

N° Archivo : 0627442
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 6346 7389

N° Epicrisis
338709

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 01/01/2023 04:28

Días Estadía: 24

Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Egreso : 25/01/2023 12:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Gran quemado

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 01/01/23
FI UCI: 01/01/23
FI IQx: 18/01/23

ANTECEDENTES:

1. Depresión con 7 intentos previos de autolisis
2. Enfisema pulmonar
3. Artrosis.

Paciente fue llevado a APS por vecinos luego de ser rescatado por bomberos de su casa que se estaba quemando. Al parecer presenta quemaduras tipo AB B en ambos brazos y en las orejas, Quemaduras tipo A en el cuello y tercio superior del tronco por anterior. En la urgencia se determina una SCQ 15% aprox. Presenta además Hollín en los dientes y la lengua, escasas vibras quemadas. Además, con cortes superficiales en el cuello y antebrazos. Se decide TOT por sospecha de quemadura de vía aérea.

Se decide traslado a UCI donde se mantuvo hasta 18/01, que se traslada a Intermedio quirúrgico para continuar su manejo con los siguientes Dx:

1. Neumonía Asociado a VM
 - E. Coli MS (13/01)
 - ATB: Imipenem (FI 15/01), cambio a Tazonam (FI 17/01)
2. Infección Tracto Urinario por E. Coli MS
3. Gran quemado x compromiso de Vía Aérea en resolución
 - En VM (01/01 al 15/01)
 - SCQ: Antebrazo D° 1% AB-A Antebrazo I° 4% AB-B en resolución
 - Aseo quirúrgico 11/01

HDN autosostenida y perfusión periférica adecuada, tendiente a la hipertensión sistólica.

Ventilatorio: buena mecánica, con apoyo de CNAF bien tolerado, Flujo 45 lt/min a 35% FiO2 PaFi 185.

Renal: Con mejoría de diuresis, función renal conservada, hipokalemia moderada con leve alcalosis metabólica. Se deja carga de K+, control AM.

Fecha Epicrisis : 25/01/2023 12:05

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 25-01-2023 12:05:40

Página 2 de 3

Infeccioso: recibe imipenem el 15/01 de forma empírica, sin nuevo peak febriles. Continuar ATB al menos 7 días. En cultivos:

-CAET E. Coli MS en abundante cantidad y K. aerogenes en escasa cantidad MS

-UC: E Coli MS > 100.000 UFC

-Cultivo punta cateter: S. epidermidis MS

-HCs I y II negativos a la fecha

-Cultivo de herida antebrazo izq intraop (-) PPII en disminución significativa,

Nutricional: adecuada tolerancia oral de licuados y líquidos claros de poco volumen.

Quirúrgico: En curaciones cada 72 hrs, el día sábado se realizó curación por EU. Re- evaluado por Cx. plástica el 17/01, con buena evolución, con indicación de continuar curaciones cada 72 hrs y en caso de alta, seguimiento ambulatorio.

Psiquiatría: Paciente con antecedente de OH crónico activo al momento de intento autolítico, además de episodio depresivo en seguimiento por Psiquiatría y 7 intentos autolíticos previos. Evaluado por psiquiatría de enlace quienes describen sin ideación suicida actual, sugiriendo ajuste farmacológico y con pase para traslado a Unidad Intermedia, manteniendo seguimiento.

Evoluciona favorablemente logrando ser desinvasado del punto de vista respiratorio, actualmente sin requerimientos de oxígeno, completo 7 días de tratamiento antibiotico por NAVM. En curaciones de EESS cada 72 hrs por enfermería. Tranquilo, a la evolución de psiquiatría sin conflicto de alta y seguimiento ambulatorio.

Diagnóstico de Egreso

QUEMADURA DE LA CABEZA Y DEL CUELLO, DE SEGUNDO GRADO -

QUEMADURA DEL HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR, DE TERCER GRADO, EXCEPTO DE LA MUÑECA Y DE LA MANO -

NEUMONIA, NO ESPECIFICADA -

INFECCION DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones generales.

Plan Post Alta

-Regimen hiposodico, papilla

-Reposo relativo

-Paracetamol 500 mg 2 comp cada 8 hrs en caso de dolor

-Losartan 50 mg al día

-Nifedipino Retard 20 mg al día

-Sertralina 50 mg al día

-Lorazepam en dosis de 1mg - 1mg - 2mg.

-Quetiapina en 100mg/noche

-Al alta, paciente debe acudir al CRS Cordillera a solicitar continuidad de controles con psiquiatra tratante.

-Control con Dra. Sonnia Perez (Cirujana Plastica) solicitar hora en pasillo 11 de CDT para control.

-Curaciones de forma ambulatoria 2 veces por semana en CDT pasillo 2 y mantener lubricacion 2 veces al día en resto de extremidades superiores (ejemplo crema lubriderm)

-No exponer extremidades ni cara al sol, uso de protector solar FPS > 30, por 2-3 veces al día

-Acudir a consultorio para continuacion de medicamentos cronicos

-Acudir a urgencias en caso de dolor que no cede con analgesicos, fiebre, imposibilidad de mantenerse hidratado o en caso de estimar necesario

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 25/01/2023 12:05

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 25-01-2023 12:05:40

Página 3 de 3

INTERNO

Becado/Residente

Valeria Galaz Kutulas

Médico Tratante (Staff)